

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

INVENTARIO CORTO DE ANSIEDAD POR LA SALUD (SHAI)

Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo • Evaluación de Hipocondría y Trastorno de Ansiedad por Enfermedad

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Inventario Corto de Ansiedad por la Salud (SHAI).
Nombre Original (Inglés)	<i>Short Health Anxiety Inventory (SHAI)</i>
Autores Originales	Paul M. Salkovskis, Katharine A. Rimes, Hilary M. C. Warwick y David M. Clark (2002).
Adaptaciones Españolas	Arnáez, García-Soriano, López-Santiago y Belloch (2019); Caballo (2006); Fernández et al. (2014).
Eje Clínico y Clasificación	Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo. Evaluación de ansiedad por la salud y somatización cognitiva.
Tipo de Instrumento	Autoinforme de 18 reactivos de 4 opciones graduadas (0 a 3) tipo Beck (14 principales + 4 de consecuencias).
Población y Rango	Adultos y adolescentes (≥ 16 años). Consultas de salud mental, medicina general y especializada.
Tiempo de Administración	5 a 9 minutos.
Régimen de Licencia	Dominio público para fines académicos, clínicos y de investigación no comercial.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO COGNITIVO

El SHAI fue diseñado por Salkovskis y colaboradores (2002) para operacionalizar el **modelo cognitivo-conductual de la ansiedad por la salud y la hipocondría**. Este modelo postula que la ansiedad patológica ante la enfermedad se origina en esquemas disfuncionales donde las sensaciones somáticas inocuas son interpretadas como signos inminentes de patología grave, letal o incurable.

A diferencia de escalas previas (como el Whiteley Index o el IBQ) que se veían muy contaminadas por la presencia real de síntomas somáticos en personas con enfermedades médicas crónicas, el SHAI fue específicamente formulado para distinguir entre **enfermedad física real** y **ansiedad desadaptativa por la salud**. El instrumento evalúa dos dimensiones cognitivas cruciales: la **probabilidad percibida** de contraer o padecer una afección grave y la **catastrofización anticipada** de las consecuencias personales y funcionales si dicha enfermedad ocurriese.

3. ESTRUCTURA FACTORIAL DE 2 SUBESCALAS (SALKOVSKIS ET AL., 2002)

Factor Clínico	Ítems	Rango Dir.	Contenido Fenomenológico y Semiológico
1. Probabilidad de Enfermedad	1 al 14	0 a 42	Preocupación intrusiva, hipervigilancia somática, rumiación médica, dificultad para tranquilizarse y conducta de reaseguro.
2. Consecuencias Negativas	15 al 18	0 a 12	Catastrofización anticipatoria: incapacidad percibida para sobrellevar la enfermedad, pérdida de dignidad, sufrimiento incurable y ser una carga.
PUNTUACIÓN TOTAL SHAI	1 al 18	0 a 54	Índice multidimensional global de gravedad de la ansiedad por la salud e hipocondría.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA

Consistencia Interna	Excelente fiabilidad: alfa de Cronbach de 0.89 en la validación española de Arnáez et al. (2019). Subescala de probabilidad = 0.86; subescala de consecuencias = 0.74.
Validez Discriminante	Diferencia de manera estadísticamente robusta entre pacientes con Hipocondría / Ansiedad por Enfermedad, pacientes con Trastorno de Pánico / TAG y sujetos controles sanos.
Rendimiento Diagnóstico	Área bajo la curva ROC (AUC) = 0.92 para el punto de corte <i>ge18</i> en la escala principal de 14 reactivos, con sensibilidad del 85% y especificidad del 87%.
Validez Concurrente	Correlación elevada con el Whiteley Index ($r = 0.73$), la Escala de Pensamientos Intrusivos sobre la Salud y la subescala somática del BAI ($r = 0.54$).
Independencia de Patología Médica	Mantiene su estructura e invariancia métrica tanto en población sin enfermedad diagnosticada como en pacientes con patologías orgánicas crónicas confirmadas.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE ÍTEMS

Cada reactivo ofrece 4 opciones graduadas valoradas de **0 a 3 puntos** referidas a las **últimas dos semanas**:

- **0** = Ausencia de preocupación / normalidad | **1** = Preocupación leve o infrecuente | **2** = Preocupación moderada / notable | **3** = Preocupación severa, constante e incapacitante.
- **Escala Principal (Ítems 1 a 14)**: Suma directa de reactivos 1 a 14. Rango: **0 a 42 puntos**.
- **Escala de Consecuencias (Ítems 15 a 18)**: Suma directa de reactivos 15 a 18. Rango: **0 a 12 puntos**.
- **Puntuación Global (Ítems 1 a 18)**: Suma total de todos los reactivos. Rango: **0 a 54 puntos**.

6. BAREMOS Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA (ARNÁEZ ET AL., 2019; SALKOVSKIS, 2002)

Nivel	Sub. 1-14	Estado Clínico	Conducta Asistencial Recomendada
Normal	0 a 14	Preocupación médica adaptativa	Preocupación basal ajustada ante estresores o síntomas comunes. Mantener hábitos de vida saludable.
Subclínico	15 a 17	Ansiedad por la salud limítrofe	Sospecha incipiente o hiperreactividad somática reactiva. Psicoeducación y observación evolutiva.
Clínico	18 a 26	Corte Positivo (Tr. Ansiedad Enf.)	Cuadro compatible con Hipocondría / Trastorno de Ansiedad por Enfermedad (DSM-5). Terapia cognitivo-conductual.
Severo	27 a 42	Ansiedad severa / Búsqueda compulsiva	Conductas compulsivas masivas de reaseguro médico, evitación de consultas o colapso funcional. Tratamiento especializado.

APLICABILIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIDADES MÉDICAS: El uso del corte de *ge18* en la subescala de 14 reactivos previene la solicitud innecesaria de pruebas diagnósticas invasivas y derivaciones redundantes a cardiología, neurología u oncología en pacientes con somatizaciones repetitivas.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA E INTERVENCIÓN COGNITIVA

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y PAUTA TERAPÉUTICA:

- **Subtipo con Búsqueda de Asistencia:** Puntuaciones altas en ítems 10 y 12 (comprobaciones corporales y visitas frecuentes a médicos). Indicación de exposición con prevención de respuesta (prohibición gradual de chequeos corporales y búsquedas en internet / "cibercondría").
- **Subtipo con Evitación de Asistencia:** Puntuaciones elevadas en ítem 11 (evitación fóbica de hospitales, noticias médicas y pruebas). Requiere desensibilización sistemática y exposición gradual a estímulos temidos relacionados con la enfermedad.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Paciente: Varón de 38 años, ingeniero informático, derivado por Neurología tras 4 resonancias magnéticas cerebrales y múltiples consultas de urgencia por fasciculaciones benignas en pantorillas y párpados, convencido de padecer Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Puntuación SHAI: Total = 39/54 (Rango Severo). Subescala Principal (1-14) = 31/42 (muy por encima del corte de 18); Subescala de Consecuencias (15-18) = 8/12 (creencia catastrófica de ruina vital absoluta ante una enfermedad neurodegenerativa).

Conducta Asistencial: Se descarta organicidad neurológica y se confirma Trastorno de Ansiedad por Enfermedad (DSM-5). Se aplica TCC según el protocolo de Salkovskis: psicoeducación sobre el bucle de hipervigilancia atencional que magnifica las sensaciones propioceptivas normales, detención de reaseguros médicos y eliminación total del rastreo compulsivo en buscadores web. A las 12 semanas, la subescala principal bajó a 12/42 (rango normal), remitiendo las consultas médicas compulsivas.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y EXPLORACIÓN COMPLEMENTARIA

ALERTA: DESCARTAR PATOLOGÍA ORGÁNICA

Antes de atribuir síntomas físicos a ansiedad por la salud, el profesional debe verificar que el paciente disponga de una valoración médica básica previa para descartar patología médica no diagnosticada.

COMORBILIDAD CON DEPRESIÓN

La catastrofización extrema en los ítems 15 a 18 suele asociarse a episodios depresivos mayores comórbidos con desesperanza y riesgo suicida latente, requiriendo exploración afectiva completa.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Salkovskis, P. M., Rimes, K. A., Warwick, H. M., & Clark, D. M. (2002). The Health Anxiety Inventory: development and validation of scales for the measurement of health anxiety and hypochondriasis. *Behaviour Research and Therapy*, 40(12), 1405–1430.
2. Arnáez, S., García-Soriano, G., López-Santiago, J., & Belloch, A. (2019). The Short Health Anxiety Inventory: Psychometric properties and construct validity in a Spanish sample. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 19(2), 154–163.
3. Luccock, M. P., & Morley, S. (1996). The health anxiety questionnaire. *British Journal of Health Psychology*, 1(2), 137–150.
4. Alberts, N. M., Hadjistavropoulos, H. D., Jones, S. L., & Sharpe, D. (2013). The Short Health Anxiety Inventory: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Anxiety Disorders*, 27(1), 68–78.